PROFESIONAL

EJE 1 Transformaciones del Cuidado y humanización

"Del cuidado a la autonomía: acompañamiento integral biopsicosocial de niños con discapacidad en un aula inclusiva"

María Leticia Faramiñan Beati

[1] PSINAF. Acompañante Terapéutico/ Asistente Personal para la Vida Independiente/ Docente de Especial del Registro de COPIDIS/ Profesora de Nivel

1 INTRODUCCIÓN

En los procesos de integración escolar y social los desafíos y cuidados más críticos giran en torno de 5 ejes primordiales

1- El sesgo "*de la presencia pasiva a la participación activa*"

2-El fenómeno "*Masking*", camuflaje social o imitación de comportamientos normotípicos escondiendo los propios

3-El deseo de conectar con otros

4-*Bournout* o sobrecarga de estímulos

5-Falta de alfabetización neurodivergente y de inteligencia emocional.

En todos ellos juega un papel central la socialización y el plano vincular en la integración. Sin ella el trabajo sería incomplete si no, imposible de llevar a cabo.

2 OBJETIVOS

Objetivo general: promover la socialización del niño garantiza gran parte del logro de una integración real.

Objetivos específicos : Que construya su identidad, autoestima y habilidades emocionales a través del intercambio genuine con los demás.

El caso de Benjamín: diagnosticado con TEA, 4 años de edad, no hablaba, ingresaba llorando a la sala y se escondía debajo de una mesa, donde permanecía gran parte de la mañana. No reconocía a los pares ni mostraba interés en hacerlo. Se trabajó en la construcción de los vínculos sociales y ello posibilitó el "*aprendizaje de contenidos*" de manera natural.

3 METODOLOGÍA

Diseño: Experiencia de un caso práctico

Ámbito y período: Ciclo lectivo años 2021/ 2022/ 2023

Población o participantes: niño de 4 años con diagnóstico de Autismo.

Intervención o procedimiento: Se intervino priorizando lo social vincular, brindando herramientas de inteligencia emocional, hacienda hincapié en las necesidades reales de la persona más allá del diagnóstico. Se cuidó de abordarlo en todo momento de una manera integral bio-psico-social conjuntamente con la familia, el equipo terapéutico externo a la escuela y la supervisión del centro de integración en trabajo de pareja pedagógica junto a la docente a cargo.

El abordaje comenzó debajo de la mesa, junto al niño. En los momentos que aceptaba salir de debajo de la mesa, se lo convocó no solo a compartir de manera oral (aumentando a diario su repertorio de palabras, gestos y expresiones) sino interactuando de manera lúdica con su grupo de pares con quienes fue construyendo un vínculo. Seguidamente comenzó a comunicar sus intereses, la mayor parte de ellos tenía que ver con la necesidad de interactuar con sus amigos. Este interés fue mutuo y genuino (base sólida sobre donde se complementó todo el resto de contenidos pedagógicos relativos al nivel)

Instrumentos y análisis: Los avances se evaluaron cada mes mediante informe solicitado por el Centro Integrador.

Aspectos éticos: La familia autorizó la publicación de las fotos y video.

4 RESULTADOS



Figura 1. *La figura muestra a Benjamín convocando a cada uno de sus compañeros para hacer un "gran abrazo grupal" . Fuente: elaboración propia*

Haciendo hincapié en las necesidades específicas de Benja, y en algunos aspectos y particularidades de su personalidad, se buscaron continuamente estrategias para fomentar la socialización cuidando que la sala no se volviera un espacio hostil o apático sino un lugar empático y receptive mitigando el estrés y la ansiedad de sentirse rechazado o segregado.

A partir de la inteligencia emocional se logró que el niño lograra ser empático y reconocer las propias emociones y las de sus pares lo que facilitó la construcción del vínculo.

No se forzaron situaciones sino que se adoptaron como naturales las propuestas por la persona y de alguna manera se le enseñaron opciones más cómodas o que favorecieran el trabajo: ***"él fue quien decidió el momento justo en el que estaba listo para salir de debajo de la mesa"***.

Esta fue la base para que el niño aprehendiera de una manera mucho más rica y sin frustraciones al mismo tiempo que construía su identidad, autoestima y habilidades emocionales en un intercambio genuine con los demás.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

Promover la socialización en los procesos de integración es una intervención de salud preventiva.

El aprendizaje es íntegramente social y afectivo.

El abordaje debe ser integral bio-psico-social haciendo hincapié no en el diagnóstico sino en las necesidades particulares de la persona.

Las limitaciones

Bullying: generando aislamiento y destruyendo la confianza.

Vaciamiento de contenidos: son muchos los aspectos que hay que tener presentes sin descuidar ninguno, el PPI (plan pedagógico individual) se debe llevar a cabo.

La falta de formación en discapacidad genera inseguridad en los adultos a cargo y conduce a la segregación o exclusión de la persona.

6 APORTE A ENFERMERÍA

Este ejemplo constituye un aporte a la salud mental.

De esta manera se previene la depresión infantil y regulación psicosocial.

Cuando la persona se siente aceptada, Segura y parte de un grupo, su cerebro reduce los niveles de estrés y active áreas dedicadas a la cognición superior.

El aporte de una adecuada socialización en la salud de las personas integradas es fundamental, ya que el lazo social actúa como un factor protector tanto de la salud mental como del neurodesarrollo.

7 REFERENCIAS

Sánchez, B. (2025). *Pues no se te nota: Camuflaje en autismo, altas capacidades y TDAH.* Editorial Autopublicación / Creadores de Contenido

Price, D. (2023). *El autismo sin máscara: Descubriendo las nuevas caras de la neurodiversidad.* Editorial Sirio.

Mora, F. (2021). *Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama* (2.ª ed.) Alianza Editorial.

Contacto: maria.faraminan@bue.edu.ar

APUBA

.UBA CIENCIAS MÉDICAS

QR (opcional)